

Incisión del plaque e injerto

WARWIKI

Información para el paciente · Cirugía para enderezar el pene (enfermedad de Peyronie)

La enfermedad de Peyronie causa una cicatriz (plaque) dentro del pene que puede curvarlo durante una erección, lo que a veces dificulta las relaciones sexuales. En esta cirugía se corta (y a veces se quita en parte) la cicatriz del lado corto y tenso del pene para liberar la curva, y el hueco se cubre con un injerto. Esta hoja explica cómo funciona, cómo prepararse y qué esperar.

Acerca de este procedimiento

Un plaque de tejido cicatricial tensa un lado del pene, así que se curva con la erección. Esta operación libera la curva al cortar la cicatriz del **lado corto (interno)**; esto abre un hueco que se rellena con un **injerto** — un parche delgado (como un parche de colágeno, tejido de donante/animal o tejido de su propio cuerpo). Como alarga el lado corto en vez de acortar el largo, **conserva la longitud del pene**.

Se usa cuando:

- Su curva es **severa o compleja** (por ejemplo, en forma de reloj de arena o de bisagra)
- Conservar su **longitud** es importante (la plicatura acortaría demasiado)
- Sus **erecciones son fuertes** para soportar esta operación

Qué saber

La ventaja es que se **conserva la longitud** (a veces aumenta un poco). La desventaja es una **mayor probabilidad de problemas de erección nuevos o peores** que con la plicatura — porque trabajar en la cicatriz puede afectar cómo el pene retiene la sangre — por eso solo se ofrece cuando sus erecciones son fuertes. El **entumecimiento de la cabeza** del pene es común al inicio (los nervios se levantan con cuidado durante la cirugía) y suele recuperarse en 6–12 meses. La mayoría de los hombres logra una erección recta para el sexo.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Enfermedad de Peyronie

Una cicatriz en el pene que lo hace curvarse durante una erección.

Plaque

El parche de tejido cicatricial que causa la curva.

Injerto

Un parche delgado que rellena el hueco tras liberar la cicatriz — un parche de colágeno, tejido de donante/animal o tejido de su propio cuerpo.

Erección artificial

Una erección creada en el quirófano (con una inyección) para que el cirujano mida y revise la curva.

Circuncisión

Extirpación del prepucio — a menudo se hace a la vez si usted no está circuncidado.

Rehabilitación del pene

Usar una pastilla para la erección o un dispositivo de vacío durante la curación para proteger las erecciones y la longitud.

Anestesia general

Medicina que lo mantiene dormido y sin dolor durante la cirugía.

¿LE DOLERÁ? La cirugía se hace con anestesia general o espinal, así que no siente nada durante ella. Después, espere hinchazón, moretones y dolor del pene por 1–2 semanas — el hielo, el soporte y los analgésicos ayudan. Esta operación dura más que la plicatura (suele ser 1.5–3 horas) y puede quedarse una noche. Por lo general se coloca una sonda y se retira a la mañana siguiente.

Cómo prepararse (antes de la cirugía)

- Se hace con **anestesia general o espinal** — siga todas las instrucciones de la cirugía (ayuno y qué medicinas suspender, incluidos los anticoagulantes).
- Su Peyronie debe estar **estable** (curva y dolor calmados por meses) y sus **erecciones se revisan** antes — esta cirugía requiere buena función eréctil.
- **No fume**; cualquier infección se trata primero y recibirá antibióticos. Si no está circuncidado, a menudo se hace una circuncisión a la vez.

Avise a su equipo con tiempo si usted:

- Tiene **erecciones débiles** o necesita medicina/inyecciones para la erección
- Toma un anticoagulante o ha tenido cirugía previa del pene

Qué sucede durante la cirugía

- 1 Está dormido o adormecido con anestesia; se administran antibióticos.
- 2 Se **crea una erección con una inyección** para mostrar la curva; se levanta la piel y los nervios de la parte superior del pene se apartan con cuidado.
- 3 La cicatriz del lado corto se **corta (y a veces se quita en parte)** para liberar la curva, y el hueco se cubre con un **injerto**; se revisa el resultado y se cierra la piel.

Después de la cirugía

- Espere **hinchazón, moretones y dolor** por 1–2 semanas. El **entumecimiento de la cabeza** del pene es común y suele recuperarse en meses.
- La sonda suele retirarse la mañana después de la cirugía.
- **Evite el sexo unas 6–8 semanas** para que el injerto cicatrice.
- Su equipo probablemente inicie la **rehabilitación del pene** — una pastilla de baja dosis para la erección o un dispositivo de vacío diario — para proteger las erecciones y la longitud.

Llame a su equipo si tiene:

- Fiebre o escalofríos, o aumento de enrojecimiento, dolor, hinchazón o secreción en la herida
- No puede orinar
- Hinchazón o dolor severo o que empeora, o sangrado abundante

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. Esta cirugía libera la curva al cortar la cicatriz del lado corto y cubrir el hueco con un injerto — **conserva la longitud** y se usa para curvas severas o complejas.
2. La desventaja es una **mayor probabilidad de problemas de erección** que la plicatura, por eso solo se ofrece con erecciones fuertes; el entumecimiento inicial de la cabeza es común y suele recuperarse.
3. Su Peyronie debe estar estable y las erecciones revisadas antes; no fume. Después, evite el sexo ~6–8 semanas y siga la rehabilitación del pene. Llame por fiebre, hinchazón severa o problemas para orinar.